

Fecha Última Actualización: 07-03-2023 22:23:52

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Luis Parada Perez
Edad : 61a 10m 2d
Dirección : Cacerab 849

Rut : 8.638.605-4
Fecha Nacto: 05/05/1961
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1034509
Sexo : Masculino
Teléfono : 2 2850 1058

N° Epicrisis
344329

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 03/01/2023 08:31
Fecha Egreso : 07/03/2023 22:03

Días Estadía: 63

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS/RESUMEN

FI CASR: 03/01/2023
FI UCI: 04/01/2023
FI UTIM: 12/01/2023
Segundo ingreso UPC: 17/01/2023
FI UTIM: 30/01/2023
Tercer ingreso UPC: 04/02/2023

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

- Mórvidos: DM 2 IR de larga data con DOB (ERC sin HD obs nefropatía diabética, con crea basal en 1.8, Pie diabético con necesidad de amputación), EAOP, HTA, Obesidad mórbida
- Quirúrgicos: Amputación infracondílea izquierda 04/12/2023
- Fármacos: Insulina, resto desconocido
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (-), suspendido hace 10 años
- Inmunizaciones: COVID-19 (+) 5 dosis

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente con amputación infracondílea el 04/12/2022 con posterior egreso a domicilio.
Ingresa el 03/01/2023 a la urgencia de esta institución por edema agudo de pulmón con requerimiento de intubación orotraqueal e ingreso a UCI el 04/01/2023 en donde evolucionó satisfactoriamente extubándose a VMNI el 10/01/2023 y egresando a UTIM del 12/01/2023.
Intercurrencias durante la primera internación en UCI
· NAVM por C. freundii + e. Cloacae, tratamiento dirigido con IMI por 7 días.
· Falla renal aguda sobre crónica * TRR 06/01/2023 al 07/01/2023
· Miopatía del paciente crítico

Fecha Epicrisis : 07/03/2023 22:23

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 07-03-2023 22:23:52

Página 2 de 3

Intercurrencias durante la internación en UTIM

- Hipertensión de difícil control
- Cultivo de punta de CVC positivo para S. epidermidis, hemocultivos negativos.
- Shock séptico 16/01/2023 * deterioro del estado de conciencia, neumonía por aspiración, falla respiratoria severa y mixta, falla renal aguda sobre crónica.

En ese contexto ingresa a UCI el 17/01/2023.

Al examen físico, RASS -4, midazolam y fentanilo, relajación neuromuscular con rocuronio; pupilas isocóricas, normorreactivas, intubado con TET 7.5 a 22 cm de arcada dentaria, buena entrada de aire bilateral, roncus y crepitantes húmedos en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo, se programa VM Vc 540 (6.4 ml KG peso ideal), PEEP 10, FR 24, FiO2 100%, presión meseta 22, PEEP total, 11, DP 11, CRO 49, Abdomen blando, depresible RHA ausentes, R1 y R2 normo fonéticos, llenado capilar 3 segundos, tibio a distal, úlcera por presión en región sacra, amputación infracondílea izquierda, muñón con bordes afrontados, sin signos de inflamación, pie derecho con lesión en empeine, de aproximadamente 3 cm * 2 cm, con signos de epitelización.

Se realizó Ecocografía, VD menor a VI, impresiona contractilidad conservada, VCI sin variabilidad, 1.9 cm de diámetro, sin líquido libre en espacios: hepatorenal y esplenorrenal, abundantes líneas B e imágenes sugerentes de consolidación en ambas bases pulmonares a predominio derecho.

Diagnósticos de ingreso UPC: (2do ingreso)

Shock séptico (foco respiratorio) con fallo orgánico múltiple

Falla respiratoria

Falla hemodinámica

Falla neurológica

Completa tratamiento antibiotico extubandose el 24/01, con resolución de fallas orgánicas, pasa a UTIM el 30/01 intercurriendo con PCR el 02/02 -ROSC 4to ciclo Ritmo: asistolia, Obs causa Hipoxica (Neumonía aspirativa) por tal motivo ingresa a UPC intubado, al suspender sedación paciente no despierta motivo por el cual se realiza RMN el 16/02 que informa Alteración de la señal del esplenio del cuerpo calloso y de la corteza supratentorial bilateral, pueden tener origen isquémico subagudo.

Se interpreta como encefalopatía hipoxico-Isquemica se define Manejo proporcional si PCR NO RCP, NO ATB, NO HD.

Se habla con familia la misma rechaza realización de TQT.

Diagnostico principal ultimo ingreso UPC:

PCR hipóxico 02/02/23

- ROSC 4to ciclo

- Ritmo: asistolia

- Obs secundario a compromiso de conciencia/sepsis

- Lesiones hipoxico-Isquemicas

En conjunto con familia se decide extubación para confort de paciente, teniendo en cuenta que paciente puede fallecer posterior a procedimiento. Se realiza procedimiento bien tolerado, horas mas tardes disminución de PA y bradicardia con gasping y se inicia bic de Mo rfin, fallece a las 21:09 horas

Se expide certificado

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía hipóxico isquémica - Falla orgánica multiple

PCR recuperado

Shock septico foco pulmonar

Antecedentes : DMIR, HTA, Nefropatía Diabética, ERC sin HD, EAOP, Amputación supracondilea izq

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 07/03/2023 22:23

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:40

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Juan Giraldo Paramo
Médico Tratante (Staff)